

17. 물질오남용

● 중요성 (rationale)

물질오남용은 개인건강에 심각한 피해를 줄 수 있기 때문에 의사는 오남용 가능 물질을 주의하여 처방해야 하고, 사용자 교육을 시행해야 하며, 물질의 오남용 판단과 의존성을 평가하여 환자를 찾아내고 그 문제를 해결하는 것이 사회 건강증진 차원에서 중요하다.

● 평가 목표

원인		
물질 오용		정해진 용법 외 사용: 처방된 용량보다 많이 복용하거나 더 자주 복용하는 행위. 목적 외 사용: 질병 치료가 아닌 쾌락, 각성, 체중 감량 등을 위해 복용. 타인의 약물 복용: 본인에게 처방되지 않은 약물을 빌려서 복용. 위험한 혼합: 약물을 술이나 다른 약물과 임의로 섞어 복용하여 부작용 위험을 높이는 경우.
물질사용장애		통제 상실: 끊으려 노력해도 조절이 안 되며, 사용에 과도한 시간을 할애함. 사회적 손상: 직장, 학교, 가정의 역할을 수행하지 못하고 대인관계 갈등이 발생함에도 지속함. 위험한 사용: 신체적·정신적 문제가 악화됨을 인지하면서도 계속 사용함 내성: 같은 효과를 얻기 위해 점점 더 많은 양이 필요함. 금단: 사용 중단 시 신체적 고통이나 정서적 불안이 나타남.
평가목표		
1) 물질을 오남용하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 의존상태와 생활과 건강에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 설명 2) 사용원칙을 교육		
구체적인 성과		
병력 청취	물질 사용 상황을 확인	종류: 술, 담배, 카페인, 수면제, 진통제, 다이어트 약, 마약류 등 정확한 물질명 용량, 빈도, 기간, 경로
	물질에 의한 영향(의존, 합병증 등) 확인	내성: 동일한 효과를 위해 양이 점점 늘어났는지 여부 금단: 중단 시 손 떨림, 식은땀, 환각, 경련, 불안 증상 발생 여부 합병증: 기억력 저하, 소화기 이상, 황달, 손발 저림, 우울, 불안, 수면 장애 등
	물질 사용 조절 능력 평가	중단 시도: 줄이거나 끊으려고 시도했다가 실패한 횟수 갈망: 물질을 사용하고 싶어 참기 힘든 강력한 충동 유무 시간 소모: 물질을 구하거나, 사용하거나, 효과에서 회복되는 데 쓰는 하루 시간 우선순위: 취미나 즐거운 활동을 물질 사용 때문에 포기했는지 여부
	물질 사용과 관련된 다른 건강 위험 평가	사회적 기능: 무단결석/결근, 직무 수행 능력 저하, 가사 소홀 대인관계: 가족이나 주변 사람과의 잦은 다툼, 사회적 고립 위험 행동: 음주/약물 상태에서의 운전, 기계 조작, 범죄 연루 감염 위험: 주사기 공동 사용 여부 (HIV, B/C 형 간염) 정신과적 공존 질환: 기저에 깔린 우울증, 조울증, 공황장애 유무
신체 진찰	물질 사용에 따른 신체 이상을 확인하는 신체진찰	활력징후 - 흥분제- 혈압 상승, 빈맥, 체온 상승 - 억제제(아편계, 수면제)- 혈압 저하, 서맥, 호흡수 저하 동공: - 축소- 아편계 중독의 전형적 징후 - 확대- 각성제, 환각제 중독 또는 아편계 금단 현상 피부 진찰: 주사 자국- 팔 안쪽, 발등 등 정맥 주사 흔적 및 농양 확인 만성 합병증: 황달(간 손상), 영양 불량 상태 신경학적 진찰: - 손떨림- 알코올이나 진정제 금단 증상 - 보행 실조- 알코올, 수면제 중독으로 인한 비틀거림

	정신상태를 평가	의식 수준, 외모 및 행동, 정동 및 기분, 사고 과정 및 내용, 망상, 자살/타살 사고, 환각, 인지 기능, 병식
진단 및 치료	물질사용장애 정도를 평가하기 위한 진단계획	소변 약물 스크리닝: 가장 흔히 쓰이는 검사. 최근 사용한 약물 확인 혈중 약물/알코올 농도, 자가 보고식 설문지
	물질 사용으로 인한 신체적 이상을 확인	전혈구검사, 간 기능 검사 (LFT), 전해질 검사 감염병 검사, 심전도 (ECG), 흉부 X-선
	물질오남용의 치료계획	해독: 체내 약물을 안전하게 배출하고 금단 증상을 조절. 인지행동치료 (CBT): 약물 사용을 유발하는 상황과 생각을 파악하고 대처법 훈련. 사회적 지지 체계: AA(단주 모임), NA(단약 모임) 등 자가조직 연계. 재발 방지 약물 - 알코올: 날트렉손(갈망 감소), 아캄프로세이트. - 아편계: 메타돈, 부프레노르핀 (대체 요법).
	합병증 및 금단증상의 치료계획	아편계 해독제: 나록손(Naloxone) - 호흡 억제 시 즉시 투여. 벤조디아제핀 해독제: 플루마제닐(Flumazenil). 알코올/BZD 금단: 벤조디아제핀(Diazepam, Lorazepam) 투여 영양 보충: 알코올 환자에게 베르니케 뇌증 예방을 위한 티아민(비타민 B1) 투여. 정신과적 공존 질환 치료: 동반된 우울증, 불안 장애에 대한 약물 및 상담 병행.
환자 교육	응급조치에 대해 교육	의식 확인 및 기도 확보: 의식이 없을 때 혀가 기도를 막지 않도록 고개를 옆으로 돌려주고(회복 자세), 입안의 이물질을 제거함. 호흡 감시: 숨을 쉬지 않거나 입술이 파래지면(청색증) 즉시 119 에 신고함. 해독제 소지 및 사용
	물질오남용에 대한 폐해와 예방 및 치료원칙	1) 물질 오남용의 폐해 신체적 폐해: 간경화, 뇌 손상(기억력 저하), 심혈관 질환, 감염성 질환(HIV, 간염) 위험성 강조. 정신적 폐해: 우울증, 불안 장애, 망상 및 환각으로 인한 판단력 상실. 사회적 폐해: 직업 상실, 경제적 파탄, 가정 붕괴 및 범죄 연루 가능성. 2) 예방 원칙 고위험 상황 회피: 약물 사용 유혹이 있는 장소나 모임 피하기. 스트레스 관리: 약물 대신 운동, 취미 생활 등 건강한 스트레스 해소 창구 마련. 처방 준수: 처방받은 약은 반드시 용법과 용량을 지키고, 남은 약은 폐기. 3) 치료 원칙 질병 인식: 중독은 의지 부족이 아니라 치료가 필요한 뇌의 질환임을 인지시킴. 장기적 접근: 단기 해독보다 중요한 것은 재발 방지이며, 최소 6 개월 이상의 장기 치료가 필요함. 다각적 치료: 약물 치료뿐만 아니라 상담(CBT), 가족 치료, 자가조직(AA, NA) 참여를 병행해야 함. 단단한 지지 체계: 가족과 주변인이 비난보다는 지지와 감시의 역할을 동시에 수행해야 함.

계에서 중독이라는 용어는 사용되지 않다가 DSM-5에서 중독성(addictive)이라는 형용사가 다시 사용되고 있다. 이 장에서는 진단명을 지칭하는 것이 아닌 경우, 기술의 편의상 중독이라는 용어를 일부 사용할 것이다.

남용[abuse(DSM-IV)]

일상적 의미와 다르게, DSM-IV에서 남용은 불필요한 물질 사용과 관련해서 부적응적 행태가 나타나는 경우만을 일컫는다. 여기에는 신체-정신적 건강 문제뿐만 아니라 사회적-법적 부적응도 포함된다.

의존[dependence(DSM-IV)] 및 사용장애(use disorder(DSM-5))

의존이란, 물질 때문에 생기는 문제에도 불구하고 지속적으로 사용하는 상태로 정의된다. 즉 사용을 조절하는 능력이 손상된 상태로서 인지-행동-생리적 증상들의 복합이다. 남용보다 심한 질환이지만 DSM-5에서는 이들을 통합해서 이전에 카테고리 명칭이었던 사용장애를 진단명으로 하고 있다.

사용장애 내에서의 심각도는 명시자(specifier)로서 구분한다(표 22-5). 다른 정신장애를 배제하는 기준이 없으므로, 다른 장애의 진단기준을 같이 만족하면 그 장애와 물질 사용장애 두 가지 다 진단하게 된다.

ICD-10 및 ICD-10-CM의 용어들

ICD-10에 정의된 해로운 사용(harmful use)은 DSM-IV의 남용보다는 범위가 좁아서 신체-정신적 건강 문제를 일으키는 경우를 말하며, 사회적 기능상의 문제만 발생하는 경우는 해당하지 않는다. 의존 증후군(dependence syndrome)은 관찰되는 행동 양상보다는 개인의 인지적 태도와 욕구의 측면을 강조하였다. 그러나 ICD-10-CM은 DSM-IV의 개념과 진단명을 받아들였다.

심리적 의존(psychological dependence)과 신체적 의존(physical dependence)

전자는 물질 추구행위에 대한 통제를 상실한 상태를 말하며 후자는 만성적인 사용의 결과 신체가 약물에 적응해서 내

표 22-5. 물질 사용장애의 DSM-5 진단기준

기준 A. 임상적으로 의미 있는 장애나 고통을 일으키는, 문제성 있는 물질 사용 패턴으로, 다음 중 최소 2가지가 12개월 기간 내에 일어남

1. 종종 의도하던 것보다 더 많이 또는 더 장기간 물질을 사용함
2. 물질 사용을 중단하거나 조절하려는 지속적인 욕구, 또는 노력해도 실패함
3. 물질 구하기, 사용하기, 효과에서 회복하기 위한 활동에 많은 시간을 소비함
4. 갈망, 물질을 사용하려는 강한 욕구와 충동
5. 물질을 거듭 사용한 결과 직장, 학교, 가정에서 중요한 역할임무를 완수하지 못함
6. 물질의 효과에 의해 지속적-반복적인 사회적-대인관계 문제가 일어나거나 악화됨에도 불구하고 계속 물질을 사용함
7. 중요한 사회, 직업 및 여가 활동이 물질 사용때문에 줄어들거나 중단됨
8. 신체적으로 위험한 상황에서도 거듭해서 물질을 사용함
9. 물질이 일으키거나 악화시켰을 것 같은 지속-반복적인 신체-정신적 문제가 있음을 알면서도 물질을 계속 사용함
10. 내성, 다음 중 하나로 정의됨
 - (a) 중독 혹은 원하는 효과를 얻기 위한 훨씬 많은 양의 물질이 필요함
 - (b) 같은 양의 물질을 계속 사용하는데 효과는 크게 감소함
11. 금단, 다음 중 하나로 나타남
 - (a) 물질에 특징적인 금단증상
 - (b) 금단증상을 줄이거나 피하기 위해 같은(또는 관계 깊은) 물질을 사용

명시자:

초기 관해: 3~12개월간 항목 4를 제외한 어떤 증상도 없음

지속적 관해: 12개월 이상 항목 4를 제외한 어떤 증상도 없음

조절된 환경에 거주: 물질에 대한 접근이 제한되는 환경에서 살고 있음

심각도:

경도: 2~3 증상

중등도: 4~5 증상

고도: 6 증상 이상

(Reprinted with permission from the Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, Fifth Edition (Copyright 2013), American Psychiatric Association.)

● 약물 정리

억제제 및 마약류

종류	약물	중독증상	부작용	금단증상	치료
진정제(BZD) 1	로라제팜(아티반),	졸음, 주의력 감퇴, 비현실감, 이인증, 호흡억제	호흡마비, 혼수, 의식저하, 저혈압, 안구진탕	불안, 경련, 섬망, 자율신경계 항진	Flumazenil, 점진적 감량
수면제 1	Z-drug (졸피뎀)	BZD 와 유사	이상 수면, 순행성 기억상실	반동성 불면증, 불안, 초조, 손떨림	Flumazenil, 수면 위생 교육
아편제 1	메페리딘(데메롤) 모르핀, 헤로인, 펜타닐, 코데인	고통 경감, 졸음, 정신 운동 지연, 핀포인트 동공 , 호흡 저하, 서맥	부교감 항진 : 동공 수축, 오심, 서맥, 호흡 억제, 진전, 경련, 섬망, 혼수, 변비	교감 저하 : 통증, 오심, 구토, 동공산대, 발열, 눈물, 콧물, 설사, 땀	중독 : Naloxone 금단 : methadone -> clonidine
마취제 3	프로포폴, 케타민	진정, 황홀감, 도취감, 회 복감	기억 상실, 무의식, 호흡 중지, 호흡 곤란, 심박수 저하, 저혈압	불안, 불면	약물 중단, 호흡 보조

흥분제 및 각성제

종류	약물	중독증상	부작용	금단증상	치료
각성제 4	메트암페타민(필로폰) 다이어트약(푸링), 엑 스터시, 카페인?	능률/성욕증가, 불안 , 착란, 동공 산대, 고열, 환시	교감 항진 동공 산대, 심계 항진, 환시, 망상, 오심, 구토, 발한, 황달	우울, 피로, 불쾌, 불안, 과수면	경하면 – 대증요법 정신병적-haloperidol 우울 – SSRI
코카인	코카인	능률/성욕증가, 불안 , 착란	비중격 천공, 기관지/폐손상	우울, 불쾌, 불안, 과수면	암페타민, TCA, bromocriptine

환각 및 기타 물질

종류	약물	중독증상	부작용	금단증상	치료
대마초	대마 (마리화나)	이완, 지각 예민	결막충혈, 식욕증가, 무욕증후군		BDZ, haloperidol
환각제	LSD, PCP	지각 풍부, 현실감 상실	무욕증후군		BDZ, haloperidol
흡입제	본드, 가스, 니스	다행감, 붓 땀, 공포, 환각	오심, 식욕 상실, 납중독, 안구진탕		흡입중단

약물 및 호르몬

종류	약물	중독증상	부작용	금단증상	치료
비마약성 진통제	진통소염제 (Aspirin, NSAIDs)	자살시도로 내원하는 경우 많음	속쓰림, 위궤양, 신기능저하, 빈맥, 발열, 의식저하, 호흡곤란		약물중단, 위세척, 활성탄
스테로이 드	아나볼릭 스테로이드 (헬스)	남성호르몬 과다 증상	여드름, 여성형 유방, 발기부전, 탈모	우울, 나른	약물 중단

무엇을/왜/언제/어디서/얼마나 -> 내성/의존성/남용/시도/금단 -> A/E/외/과/약/사/가 -> PEx (생략 가능) -> 진단/검사-> 설득 -> 격려/조력 -> 전략/금단/대처 -> 위험성 -> 약속

시작		안녕하세요. 학생의사 000 입니다. 환자분 성함과 등록번호 확인하겠습니다. 날씨도 쌀쌀한데 오시느라 고생하셨습니다. 지금부터 제가 몇 가지 여쭙보고 신체 진찰도 진행하려고 하는데 괜찮으신가요? 오늘은 어떤 일로 내원하셨나요? 오늘 말씀하시는 내용은 비밀 보장이 되고 진료 목적 외에 사용되지 않으니 안심하고 편하게 말씀해주세요.		
상황		어떤 약을 복용하시나요? 왜 복용하려고 하시나요?		
O		언제부터		
L		어디서 처방		
D		얼마나 자주, 한번에 몇 개씩		
Co		예전보다 복용량이 느셨나요? (내성 확인) 같은 양을 써도 효과가 예전보다 떨어지나요?		
Ex		이전에도		
C	의존	약을 복용했을 때 어떤 효과가 있나요? - 진정제 : 졸림/주의력 감퇴/비현실감/이인증 - 마취제 : 진정/황홀감/도취감/회복감 - 각성제/코카인 : 능률/성욕 증가/착란/환시 - 아편계 : 통증 감소/정신운동지연/졸음/식욕저하 - 환각제 : 현실감 상실/환각		
	남용	[법적] 약 복용과 관련하여 법률적 문제가 생긴 적이 있나요? [의무] 약 복용으로 인해 결근/결석 하거나 중요한 할 일을 못하진 않았나요? (자녀 돌보기, 집안일 등) [관계] 약 복용 문제로 가족이나 주변 사람들에게 반복적으로 지적을 받거나 싸우나요? / 인간관계에 문제가 생긴 적 있나요? [여가] 약 복용으로 여가 활동 시간을 포기하게 되나요? [신체] 약 복용으로 인해 스스로에게 해를 입힌 적이 있는지? / 신체가 안 좋아져도 약을 복용하게 되나요?		
	시도 금단	[시도] 약물을 끊어보려 한 적이 있나요?(자발/비자발) 몇번이나 있나요? 얼마나 오래 성공했나요? 실패한 이유는 뭔가요? [금단] 약을 복용하지 못했던 적이 있나요? 어떤 증상이 있었나요? 다시 복용하면 좋아졌나요? 금단증상 진정제 : 불안/경련/두근거림/초조/자율신경계 항진 각성제/코카인 : 우울/불쾌/불안/과수면/기억력, 집중력 저하/졸림/나른함 아편계 : 통증/오심/구토/발열/눈물/콧물/설사		
A		[순환/호흡] 호흡곤란, 두근거림 [소화] A/N/V/D/C [신경] 두통/어지럼/의식소실/경련/손떨림 [정신] 우울/불안/불면		
외		수술/외상/입원		
과		HTN/DM/간/신장/정신과		
약		복용중인 다른 약물		
사		음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동		
가		약물 복용, 정신과 진료		
여		임신가능성		
PEx		동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-눈-입-팔다리-흉부-복부-신경		
		<table><tr><td>기본</td><td>V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 G/A: 의식수준, 전반적인 위생 상태 2 눈: 동공산대/축소, 안구진탕, 빈혈, 충혈, 황달 3 입: 탈수, 분비물 4 팔다리: 자살시도 흔적, 하지 부종 5 흉부: 호흡음, 심음 6 복부: 시청타촉 + 간 7 신경: 감각, 운동, DTR</td></tr></table>	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 G/A: 의식수준, 전반적인 위생 상태 2 눈: 동공산대/축소, 안구진탕, 빈혈, 충혈, 황달 3 입: 탈수, 분비물 4 팔다리: 자살시도 흔적, 하지 부종 5 흉부: 호흡음, 심음 6 복부: 시청타촉 + 간 7 신경: 감각, 운동, DTR
기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 G/A: 의식수준, 전반적인 위생 상태 2 눈: 동공산대/축소, 안구진탕, 빈혈, 충혈, 황달 3 입: 탈수, 분비물 4 팔다리: 자살시도 흔적, 하지 부종 5 흉부: 호흡음, 심음 6 복부: 시청타촉 + 간 7 신경: 감각, 운동, DTR			
		협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요?		

	손씻기
감별진단 /검사	지금까지 지금까지 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 ~ 한 것으로 보아 ~ 약물에 중독 증상이 있으며, 의존성이 꽤 높은 것으로 판단됩니다. 이로 인해 뇌, 간 등 신체 기관에 손상이 생기지는 않았는지 추가 검사가 필요합니다. 정확한 진단을 위해 혈액검사를 통해 간기능, 신기능 검사, 소변검사가 필요할 것으로 보이는데 괜찮으신가요? (자살 위험 있거나 금단 증상이 심한 경우 - 섬망, 경련) 저는 000 님에게 입원하셔서 의료진의 도움을 받으며 치료하시는 것을 권해드립니다. 입원 치료하게 되면 불편하신 증상을 더 신속하게 해결할 수 있고, 약을 끊으실 수 있는 확률도 올라갑니다. (급성 중독 증상이 있을 경우) 지금 000 님은 과량의 약물을 복용한 상태이기 때문에, 먹은 지 얼마 되지 않았다면 위세척이 필요할 수 있습니다. 이미 몸에 흡수된 뒤라면 수액을 드려 약의 농도를 희석시키고 약의 종류에 따라 알맞은 해독제가 있다면 해독제를 투여할 수도 있습니다.
설득	말씀드린 대로, ~ 약물 때문에 ~한 증상이 있는 것으로 생각됩니다. 000 님께서는 약물을 중단할 의사가 있으신가요? YES : 이번에 병원에 오지게 되어 다행입니다. 그동안 ~ 증상 때문에 많이 힘드셨을텐데, 제가 약물을 끊으실 수 있도록 최대한 도와드리겠습니다. NO : 환자분께서 ~ 약물을 ~ 정도로 평소에 자주 드신다고 하셨습니다. 지금까지는 특별한 문제가 없었을지라도 이 약은 ~과 같은 심각한 부작용이 생길 수 있는 약입니다. 또한 점점 내성이 발생하고 약을 못 먹게 되었을 때의 금단 증상이 심해질 수 있습니다. 약물을 과복용하게 되었을 경우 숨이 안 쉬어 지거나 의식이 떨어지는 일 까지 발생할 수 있기 때문에 오늘 병원에 오셨을 때 약물을 서서히 중단하실 수 있도록 도와드리고 싶은 데 어떻게 생각하시나요? 계속 처방해 달라고 할 때: 네 저도 000 님의 마음을 이해합니다. 그렇지만 000 님께 궁극적으로 도움보다 해를 더 많이 끼칠 것을 알면서도 약을 드릴 수는 없습니다. 지금까지 약으로 얻어온 효과를 다른 방식으로 대체하고, 약을 끊는 과정에서 금단증상을 줄일 수 있도록 도와드릴 테니 이번 기회에 약을 끊어보시는게 어떨까요?
격려	그동안 써오던 약을 끊는 것이 결코 쉽지 않은 일임을 잘 알고 있습니다. 약을 끊는 과정에서 예상치 못한 어려움을 만날 수 있지만, 낙담하거나 포기하지 마시길 바랍니다. 오늘 정말 큰 결심을 해주신만큼, 저희도 최선을 다해 000 님께서 약 없이도 잘 지내실 수 있도록 도와드리겠습니다.
전략/금단 /대처	약물을 갑자기 끊으면 경련이나 의식저하/섬망 등 금단 증상이 생길 수 있으니, 길항제, 대체 약물 등으로 서서히 약물의 필요량을 줄이고 해독시키도록 하는 것이 좋을 것 같습니다. 많이 힘드시다면 금단증상을 줄여주는 약물 드릴 수 있으니, 어려움이 있다면 언제든지 말씀하시기 바랍니다. 효과가 없다면 약을 증량하는 것이 아니라 다른 약으로 교체하거나 다른 치료방법을 고려해보는 것이 좋습니다. + 약물 중독 환자분들의 재활 모임이나 가족 모임에 소개해드리고 함께 이겨나갈 수 있도록 도와드리겠습니다.
위험성	약물을 과복용하면 숨이 잘 안 쉬어질 수 있고, 토하게 되면서 질식하실 수도 있어요. 또 약물로 인해 넘어지거나 판단을 제대로 못하게 될 경우 외상을 입을 수도 있습니다. 혹시라도 숨이 차거나 쓰러질 것 같이 힘드시다면 수액 치료가 필요할 수 있으니 병원에 방문해 주세요.
약속	다음주에 다시 외래에 방문하셔서 그동안 어떤 것들이 힘들었는지 확인하고 그에 따라서 조절해보도록 하겠습니다. 그 전에라도 신체적, 정신적으로 많이 힘드시는 언제든지 찾아오셔도 좋습니다. 마지막으로 궁금한 점 있으세요? 없으시면 다음주에 뵙겠습니다. 오늘 고생 많으셨습니다.